本篇仅为个人就医经验分享，不作医学指导，如有不当欢迎指正！by 宋宋

◎病因：门脉高压常见原因有乙肝、丙肝、自免肝、酒精损伤和药物损伤等。对于胰腺癌病人，还常见胰源性这个因素。本篇主要解释药物损伤造成肝脏窦后小静脉堵塞和胰源性叠加引起区域性门脉高压（也称“左侧门脉高压”或“局限性门脉高压”）的一些情况。

◎诊断：

1、肉眼观察：单纯区域性门脉高压引发的腹水，一般呈现颜色偏黄、透明无杂质的状态。

2、影像检查：一般在腹部增强 CT 或门静脉 CTA 报告中可见食管胃周静脉多发迂曲增粗（或“侧支循环”、“扩张”等），脾稍大（或“增大”），肝脏区域性功能减退等用词。更明显一点会直接报门脉高压。如果肿瘤侵犯过结肠系膜静脉等血管，也可能在这些位置报侧支循环。

3、腹水检查：（1）脱落细胞检查。排查癌性因素，但即便真的有癌细胞，此方法也很难检出，有效率低；（2）腹水常规项目化验。常见胸腹水总蛋白高、李凡他试验阳性（或“弱阳性”）白细胞计数高；（3）腹水肿标化验。常见 ca125 值高。

4、介入方法：由于区域性门脉高压患者可能肝功能正常，在影像上也不明显，比如门静脉正常、无肝硬化表现等，较难确诊，可以肝静脉造影+血管内压力梯度测定，此方法虽然相对伤害性低，但不够准确且仍会有一定的身体负担，建议尽量使用上述病因排除诊断，不使用介入手段。

◎问诊推荐：

1、消化内科：各地都有成熟的科室，在此不作推荐；

2、介入与血管外科：北京空总褚建国、苏二靳勇、北医大三院王昌明、肿瘤科学院李肖、天津市一陈光。

3、肝脏内科、感染科：这两个学科是互通的。感染科还考虑腹水原因有肝脓肿的可能,微小肝脓肿在影像上不明显,但腹水常见浑浊状态。

◎解决方案：

1、针对药物损伤：每个人的敏感药物不同，有些人输血都会造成肝脏窦后小静脉堵塞,无法通过检查找出敏感药物,最好在腹水出现（或“加重”）时，分析之前使用了什么药物,排查后避免使用敏感药物。

2、针对胰源性:(1)抗肿瘤治疗；(2) 脾切除/脾动脉栓塞；(3) 狭窄血管或肝内放置支架。

3、腹水治疗以输人血白蛋白＋利尿剂为主。

◎问诊心得：

如非必要不做手术！如非必要不做手术！

如非必要不做手术！如非必要不做手术！

原因如下：(1) 胰腺癌病人出现区域性门脉高压的原因经常是多因素叠加的，不是解决单一方面就能解决整体；(2) 手术（包含介入）会造成很大的身体伤害，基本无法完全避免肝脏损伤，不利于后续化疗等抗肿瘤治疗；(3) 肝内介入可能会引发肝性脑病、肝衰竭等，与医生和肝病病友沟通得知,本身肝功能正常的人在介入后出现肝性脑病的概率很低,但只是概率低，不是没有，何况还有肝衰竭等风险；(4) 窦后小静脉堵塞不能因血管恢复畅通而得到完全缓解，恢复程度视个人情况而定；(5) 区域性门脉高压首要风险是出血，应充分评估，如风险较低，可以持续观察、保守治疗；(6) 门脉高压会长期存在，腹水不会完全消失，在无生命危险的基础上以保证体感为主。